

产后综合康复干预对剖宫产产妇产后子宫复旧、母乳喂养及生活质量的影响分析

汤晶玉 王福平

【摘要】目的 分析产后综合康复干预对剖宫产产妇产后子宫复旧、母乳喂养及生活质量的影响。**方法** 66例行剖宫产产妇,根据随机数字表法分为常规组和实验组,每组33例。常规组实施常规康复干预,实验组实施产后综合康复干预。对比两组干预前后乳房胀痛程度、母乳喂养情况、生活质量,干预后子宫复旧情况。**结果** 干预后,两组乳房胀痛程度均较本组干预前改善,且实验组改善程度优于常规组,差异具有统计学意义($P<0.05$)。干预后,两组泌乳优良率均高于本组干预前,且实验组泌乳优良率90.91%高于常规组的69.70%,差异具有统计学意义($P<0.05$)。干预后,实验组宫底高度(10.06 ± 2.91)cm低于常规组的(12.25 ± 3.16)cm,宫缩疼痛时间(2.23 ± 0.27)d、恶露时间(2.36 ± 0.46)周短于常规组的(3.02 ± 0.62)d、(3.61 ± 0.56)周,差异具有统计学意义($P<0.05$)。干预后,两组生理功能、生理职能、躯体疼痛、总体健康、社会功能、情感职能、精神健康、睡眠质量评分均高于本组干预前,且实验组生理功能、生理职能、躯体疼痛、总体健康、社会功能、情感职能、精神健康、睡眠质量评分分别为(77.09 ± 7.96)、(79.15 ± 5.49)、(82.22 ± 8.77)、(92.56 ± 3.96)、(87.25 ± 12.45)、(91.23 ± 12.13)、(91.54 ± 12.17)、(86.01 ± 13.45)分,高于常规组的(61.56 ± 5.50)、(66.88 ± 3.69)、(66.01 ± 7.58)、(62.27 ± 3.58)、(70.13 ± 11.42)、(77.08 ± 11.33)、(78.87 ± 10.16)、(77.33 ± 12.02)分,差异具有统计学意义($P<0.05$)。**结论** 对剖宫产产妇给予产后综合康复干预效果显著,其能够降低产妇乳房胀痛程度,改善母乳喂养、子宫复旧情况,提高生活质量,预后佳。

【关键词】 产后综合康复干预;剖宫产产妇;子宫复旧;母乳喂养;生活质量;影响

DOI: 10.14163/j.cnki.11-5547/r.2023.20.046

Effect analysis of postpartum comprehensive rehabilitation intervention on uterine involution, breast feeding and quality of life of cesarean section parturients TANG Jing-yu, WANG Fu-ping. Weihai Second Municipal Hospital Affiliated to Qingdao University, Weihai 264200, China

【Abstract】Objective To analyze the effect of postpartum comprehensive rehabilitation intervention on uterine involution, breast feeding and quality of life of cesarean section parturients. **Methods** A total of 66 cases of cesarean section parturients were divided into conventional group and experimental group according to random numerical table, with 33 cases in each group. The conventional group received rehabilitation intervention, and the experimental group received postpartum comprehensive rehabilitation intervention. The degree of breast tenderness, breast feeding, quality of life before and after treatment, and uterine involution after intervention were compared between the two groups. **Results** After intervention, the degree of breast tenderness in both groups was improved compared with that before intervention in this group, and the improvement in the experimental group was better than that in the conventional group. The differences were statistically significant ($P<0.05$). After intervention, the excellent rate of lactation in both groups was higher than that before intervention in this group, and the excellent rate of lactation of 90.91% in the experimental group was higher than that of 69.70% in the conventional group. The differences were statistically significant ($P<0.05$). After intervention, the fundal height of (10.06 ± 2.91) cm in the experimental group was lower than that of (12.25 ± 3.16) cm in the conventional group; the duration of contraction of (2.23 ± 0.27) d and lochia time of (2.36 ± 0.46) weeks in the experimental group were shorter than those of (3.02 ± 0.62) d and (3.61 ± 0.56) weeks in the conventional group; the differences were statistically significant ($P<0.05$). After intervention, the scores of physical functioning, role-physical, bodily pain, general health, social functioning, role-emotional, mental health and sleep quality in both groups were higher than those before intervention in this group; the scores of physical functioning, role-physical, bodily pain, general health, social functioning, role-emotional, mental health and sleep quality in the experimental group were (77.09 ± 7.96), (79.15 ± 5.49), (82.22 ± 8.77), (92.56 ± 3.96), (87.25 ± 12.45), (91.23 ± 12.13), (91.54 ± 12.17) and (86.01 ± 13.45) points, which were higher than those of (61.56 ± 5.50), (66.88 ± 3.69), (66.01 ± 7.58), (62.27 ± 3.58), (70.13 ± 11.42),

(77.08 ± 11.33), (78.87 ± 10.16) and (77.33 ± 12.02) points in the conventional group; the differences were statistically significant ($P < 0.05$). **Conclusion** The effect of postpartum comprehensive rehabilitation intervention on uterine involution of cesarean section parturients is significant, which can reduce the degree of breast tenderness, improve breast feeding, uterine involution, and quality of life, and have a good prognosis.

【Key words】 Postpartum comprehensive rehabilitation intervention; Cesarean section parturients; Uterine involution; Breast feeding; Quality of life; Effect

子宫复旧是剖宫产产后较为常见的并发症,临床表现为腰痛、下腹坠胀、血性恶露淋漓不尽,甚至大量出血。即使恶露停止,白带、黄带必定增多,子宫位置后倾。子宫稍大且软,或有轻度压痛。如果不及时治疗还可能导致永久性子宫改变^[1,2],例如结缔组织增生、子宫增大、哺乳期后月经量多、经期延长等。有研究表明,剖宫产产后子宫复旧较自然分娩者速度慢;剖宫产女性子宫修复不良及宫腔积血发生率显著增高^[3,4]。因此,临床应对剖宫产产妇子宫复旧情况加以重视。故本文观察产后综合康复干预对剖宫产产妇子宫复旧、母乳喂养及生活质量的影响。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2021年10月~2022年10月本院行剖宫产产妇66例作为研究对象,根据随机数字表法分为常规组和实验组,每组33例。常规组年龄22~38岁,孕周38~41周;实验组年龄21~37岁,孕周37~42周。两组产妇一般资料比较差异无统计学意义($P > 0.05$),具有可比性。

1.2 方法 常规组实施常规康复干预,密切观察产妇生命体征,叮嘱注意睡眠及水分。实验组实施产后综合康复干预,具体如下。①产后要及时排尿,这样才不会使膀胱过胀或经常处于膨胀状态。卧床休息时尽量采取左侧或右侧的姿势,避免仰卧,以防子宫后倾;如果子宫已经向后倾屈,应做膝胸卧位来纠正。产后要注意阴部卫生,以免引起生殖道炎症,进一步影响子宫的恢复。分娩后,可引起外阴轻度的水肿,3周内自行消失。如果注意局部清洁和护理,会阴部的轻度裂伤或会阴的切口,一般都能在5d内愈合。如果会阴重度裂伤或伤口感染,切口裂开会增加产妇的痛苦,需要2周甚至1个月后方可痊愈。②产后热敷子宫,可以起到暖宫的效果,有活血化瘀,缓解疼痛的作用,会帮助子宫收缩恢复,促使淤积在子宫里面的血液排出体外。热敷时不能太烫,以免烫伤皮肤。③指导产妇母乳喂养姿势,不要让婴儿太过贴近胸部,当其位于正确的位置,而开始吸吮时,会发现婴儿的太阳穴与耳朵微微地颤动。如果婴儿的位置正确,就不会觉得乳头肿痛。在胸部下方,用一只手平贴在肋骨上,支撑起胸部。避免压迫到胸部顶端,因为这样很可能会使乳头的方向改变,从而使乳腺阻塞。每到下一次哺乳,都要换不同的乳房来哺育。在不同的时间哺乳婴儿时,让其吸吮不同的乳房,有助于避免一边的胸部受到太大

压力。哺乳前,在胸部撒一些温水,有助于乳汁的分泌,如此婴儿就不需要费力地从坚硬而疼痛的乳头吸吮乳汁。假如乳房变硬,可以用手把奶挤出,以方便婴儿吸吮。哺乳后,用冰冷的毛巾擦拭乳房,可以收缩血管,降低乳房肿胀的程度。④通过下腹部按摩子宫。产妇排空膀胱以后仰卧在床上,将下肢略为屈曲,放松身体,双手放在下腹部肚脐和耻骨联合的中间部,适当施压进行按摩。每次坚持按摩10 min左右,按摩3~4次/d。⑤对产妇进行生物反馈疗法,产妇可以直观地感知其盆底肌的功能状态,学会如何适当地放松和收缩盆底肌,通过锻炼,帮助受损盆底神经肌肉恢复,改善血供,提高肌力,促进整个盆底肌肉功能恢复,从而改善症状。

1.3 观察指标及判定标准 ①对比两组干预前后乳房胀痛程度,分为轻度、中度、重度^[5,6]。②对比两组干预前后母乳喂养情况,泌乳量无法满足新生儿喂养需求为泌乳量少;泌乳量仅能满足新生儿部分生理需求,需要奶粉辅助为泌乳量中;哺乳新生儿后仍有大量乳汁排出为泌乳量充足^[7-9]。泌乳优良率=(泌乳量充足+泌乳量中)/总例数×100%。③对比两组干预后子宫复旧情况,包括宫底高度、宫缩疼痛时间、恶露时间,测量宫底与耻骨上缘之间距离,距离越长表示子宫复旧情况越差^[10,11]。④对比两组干预前后生活质量,包括生理功能、生理职能、躯体疼痛、总体健康、社会功能、情感职能、精神健康、睡眠质量,每项0~100分,分数越高表示生活质量越优^[12]。

1.4 统计学方法 采用SPSS22.0统计学软件对研究数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差($\bar{x} \pm s$)表示,采用 t 检验;计数资料以率(%)表示,采用 χ^2 检验;等级计数资料采用秩和检验。 $P < 0.05$ 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组干预前后乳房胀痛程度对比 干预前,两组乳房胀痛程度对比差异无统计学意义($P > 0.05$);干预后,两组乳房胀痛程度均较本组干预前改善,且实验组改善程度优于常规组,差异具有统计学意义($P < 0.05$)。见表1。

2.2 两组干预前后母乳喂养情况对比 干预后,两组泌乳优良率对比差异无统计学意义($P > 0.05$);干预后,两组泌乳优良率均高于本组干预前,且实验组泌乳优良率90.91%高于常规组的69.70%,差异具有统计学意义。

义 ($P<0.05$)。见表 2。

2.3 两组干预后子宫复旧情况对比 干预后, 实验组宫底高度低于常规组, 宫缩疼痛时间、恶露时间短于常规组, 差异具有统计学意义 ($P<0.05$)。见表 3。

2.4 两组干预前后生活质量对比 干预前, 两组生理功能、生理职能、躯体疼痛、总体健康、社会功能、

情感职能、精神健康、睡眠质量评分对比差异无统计学意义 ($P>0.05$) ; 干预后, 两组生理功能、生理职能、躯体疼痛、总体健康、社会功能、情感职能、精神健康、睡眠质量评分均高于本组干预前, 且实验组高于常规组, 差异具有统计学意义 ($P<0.05$)。见表 4。

表 1 两组干预前后乳房胀痛程度对比 [n(%)]

组别	例数	时间	轻度	中度	重度
常规组	33	干预前	5(15.15)	9(27.27)	19(57.58)
		干预后	11(33.33)	12(36.36)	10(30.30)
实验组	33	干预前	2(6.06)	11(33.33)	20(60.61)
		干预后	17(51.52)	13(39.39)	3(9.09)

注 : 组内干预前后对比, $P<0.05$; 组间干预后对比, $P<0.05$

表 2 两组干预前后母乳喂养情况对比 [n(%)]

组别	例数	时间	泌乳量少	泌乳量中	泌乳量充足	泌乳优良
常规组	33	干预前	18(54.55)	7 (21.21)	8(24.24)	15(45.45)
		干预后	10(30.03)	15(45.45)	8(24.24)	23(69.70) ^a
实验组	33	干预前	17(51.52)	8(24.24)	8(24.24)	16(48.48)
		干预后	3(9.09)	11(33.33)	19(57.58)	30(90.91) ^{ab}

注 : 与本组干预前对比, ^a $P<0.05$; 与常规组干预后对比, ^b $P<0.05$

表 3 两组干预后子宫复旧情况对比 ($\bar{x} \pm s$)

组别	例数	宫底高度 (cm)	宫缩疼痛时间 (d)	恶露时间 (周)
常规组	33	12.25 $\pm$ 3.16	3.02 $\pm$ 0.62	3.61 $\pm$ 0.56
实验组	33	10.06 $\pm$ 2.91 ^a	2.23 $\pm$ 0.27 ^a	2.36 $\pm$ 0.46 ^a
<i>t</i>		2.929	6.711	9.908
<i>P</i>		0.005	0.000	0.000

注 : 与常规组对比, ^a $P<0.05$

表 4 两组干预前后生活质量对比 ($\bar{x} \pm s$, 分)

组别	例数	生理功能		生理职能		躯体疼痛		总体健康	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
常规组	33	54.09 $\pm$ 3.55	61.56 $\pm$ 5.50 ^a	50.76 $\pm$ 2.88	66.88 $\pm$ 3.69 ^a	50.43 $\pm$ 3.76	66.01 $\pm$ 7.58 ^a	51.87 $\pm$ 4.91	62.27 $\pm$ 3.58 ^a
实验组	33	53.09 $\pm$ 3.92	77.09 $\pm$ 7.96 ^{ab}	50.99 $\pm$ 2.53	79.15 $\pm$ 5.49 ^{ab}	50.15 $\pm$ 3.94	82.22 $\pm$ 8.77 ^{ab}	51.35 $\pm$ 4.87	92.56 $\pm$ 3.96 ^{ab}
<i>t</i>		1.086	9.221	0.345	10.656	0.295	8.033	0.432	32.595
<i>P</i>		0.281	0.000	0.731	0.000	0.769	0.000	0.667	0.000

组别	例数	社会功能		情感职能		精神健康		睡眠质量	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
常规组	33	61.36 $\pm$ 10.37	70.13 $\pm$ 11.42 ^a	60.09 $\pm$ 10.25	77.08 $\pm$ 11.33 ^a	60.51 $\pm$ 10.15	78.87 $\pm$ 10.16 ^a	61.11 $\pm$ 10.75	77.33 $\pm$ 12.02 ^a
实验组	33	61.24 $\pm$ 10.34	87.25 $\pm$ 12.45 ^{ab}	60.21 $\pm$ 10.18	91.23 $\pm$ 12.13 ^{ab}	60.06 $\pm$ 10.13	91.54 $\pm$ 12.17 ^{ab}	61.87 $\pm$ 10.33	86.01 $\pm$ 13.45 ^{ab}
<i>t</i>		0.047	5.821	0.048	4.897	0.036	4.591	0.293	2.764
<i>P</i>		0.962	0.000	0.962	0.000	0.971	0.000	0.771	0.007

注 : 与本组干预前对比, ^a $P<0.05$; 与常规组干预后对比, ^b $P<0.05$

3 讨论

许多研究表明剖宫产产后子宫复旧不全率较自然分娩者高, 故对剖宫产产妇实施针对性的康复干预显得尤为重要。而运用产后综合康复干预可以帮助产后剖宫产产妇进行子宫复旧, 通过产后热敷、按摩子宫等措施, 促进子宫局部血液循环, 帮助子宫肌纤维收

缩, 排出恶露, 加快子宫复旧^[13, 14]。

产后综合康复干预能够改善剖宫产妇产后康复效果, 加速产后子宫恢复^[15]。本研究结果显示 : 干预后, 两组乳房胀痛程度均较本组干预前改善, 且实验组改善程度优于常规组, 差异具有统计学意义 ($P<0.05$)。干预后, 两组泌乳优良率均高于本组干预前, 且实

验组泌乳优良率 90.91% 高于常规组的 69.70%, 差异具有统计学意义 ($P<0.05$)。干预后, 实验组宫底高度 (10.06 ± 2.91)cm 低于常规组的 (12.25 ± 3.16)cm, 宫缩疼痛时间 (2.23 ± 0.27)d、恶露时间 (2.36 ± 0.46)周短于常规组的 (3.02 ± 0.62)d、(3.61 ± 0.56)周, 差异具有统计学意义 ($P<0.05$)。干预后, 两组生理功能、生理职能、躯体疼痛、总体健康、社会功能、情感职能、精神健康、睡眠质量评分均高于本组干预前, 且实验组生理功能、生理职能、躯体疼痛、总体健康、社会功能、情感职能、精神健康、睡眠质量评分分别为 (77.09 ± 7.96)、(79.15 ± 5.49)、(82.22 ± 8.77)、(92.56 ± 3.96)、(87.25 ± 12.45)、(91.23 ± 12.13)、(91.54 ± 12.17)、(86.01 ± 13.45)分, 高于常规组的 (61.56 ± 5.50)、(66.88 ± 3.69)、(66.01 ± 7.58)、(62.27 ± 3.58)、(70.13 ± 11.42)、(77.08 ± 11.33)、(78.87 ± 10.16)、(77.33 ± 12.02)分, 差异具有统计学意义 ($P<0.05$)。探究原因发现: ①护理人员辅助产妇进行正确的母乳喂养, 当婴儿吸吮乳头可反射性引起神经垂体释放缩宫素, 从而引起子宫收缩, 促进子宫恢复。此外, 通过母乳喂养可以使产妇内分泌水平保持在正常状态, 促进泌乳素的分泌, 增加乳量。②护理人员为产妇进行热敷、按摩子宫, 可以促进产妇局部血液循环, 从而促进子宫内膜生长和发育, 有利于身体的恢复, 继而改善生活质量。③护理人员为产妇进行生物反馈疗法, 可以使受损伤的肌肉、神经得到真正的纠正, 进一步改善盆底功能, 提高预后。

综上所述, 对剖宫产产妇给予产后综合康复干预效果显著, 其能够降低产妇乳房胀痛程度, 改善母乳喂养、子宫复旧情况, 提高生活质量, 预后佳。

参 考 文 献

- [1] 汪苗. B-Lynch 缝合术对剖宫产宫缩乏力性产后出血产妇止血成功率及并发症的影响. 实用妇科内分泌电子杂志, 2022, 9(12):31-33.
- [2] 俞舒舒, 张红, 苏晓涵, 等. 妊娠合并巨大儿剖宫产术中同时行子宫肌瘤剥除术的临床分析. 中国妇幼健康研究, 2022, 33(11):113-118.
- [3] 钱佳丽. 舒适护理在剖宫产产妇手术中的应用效果. 实用妇科内分泌电子杂志, 2022, 9(11):123-125.
- [4] 张圣禄, 赖江龙, 郑巧英. 重度子痫前期产妇在全麻、CSEA 剖宫产术后纤溶指标的变化以及围术期失血情况调查. 医学理论与实践, 2022, 35(21):3697-3699.
- [5] 王懿, 吴婉林. 单叶产钳应用于再次剖宫产分娩的临床价值分析. 大医生, 2022, 7(21):13-16.
- [6] 邓宇鲲, 陈涛, 赵一冰. 经阴道超声测量剖宫产术后再次妊娠女性孕晚期子宫前壁下段厚度的临床价值. 中国医刊, 2022, 57(11):1207-1210.
- [7] 徐静, 徐萌艳. 剖宫产后再次妊娠分娩决策的研究进展. 中国乡村医药, 2022, 29(20):83-85.
- [8] 熊文娟, 尹娜. 剖宫产术后再次妊娠孕妇瘢痕妊娠发生的影响因素. 河南医学研究, 2022, 31(20):3777-3779.
- [9] 朱玉瑶, 武瑞瑞, 游璐. 俯卧式体位引流在羊水污染剖宫产新生儿中的应用. 全科护理, 2022, 20(30):4244-4246.
- [10] 朱林夕. 超声引导腹横肌平面阻滞联合七氟醚全麻对剖宫产产妇应用研究. 罕见疾病杂志, 2022, 29(10):74-75, 78.
- [11] 王丹, 杨玲. 床旁胃超声评估剖宫产者围术期胃容量的临床价值. 临床超声医学杂志, 2022, 24(10):787-789.
- [12] 刘轶, 黄元香, 刘根凤, 等. B 超复合神经刺激仪下腹横筋膜阻滞在剖宫产快速康复中的应用. 右江医学, 2022, 50(10):742-745.
- [13] 韩慧远, 程小侠, 张彩霞, 等. 新产程时限管理联合个性化音乐疗法在初产妇分娩过程中的应用及其对产时疼痛焦虑、产后盆底功能的影响. 中国性科学, 2022, 31(10):94-98.
- [14] 任晓妍. 全凭静脉麻醉在初产妇剖宫产分娩麻醉中的应用效果及对血流动力学指标的影响. 罕见疾病杂志, 2022, 29(10):66-67.
- [15] 陶新梅, 曾利. 羊水过少孕产妇胎盘和胎膜中 AQP9、HGF 的表达变化及其与妊娠结局的相关性. 中国妇幼健康研究, 2022, 33(10):59-64.

[收稿日期: 2022-12-06]